

令和8年第3回小金井市議会定例会

議事日程（第6号）

令和8年9月4日（金）午前10時開議

1		一般質問
---	--	------

進 行 予 定 表 (案)

令和8年9月4日(金)

令和8年第3回定例会

第6日

順	会 議 別	内 容
1	本 会 議	1 開議宣告 2 一般質問 (1) 藤 川 賢 治 議 員 (2) 中 井 れい子 議 員 (3) 遠 藤 百合子 議 員 (4) 水 上 洋 志 議 員 (5) 安 田 けいこ 議 員 (6) 坂 井 えつ子 議 員
2	議会運営委員会 及び同協議会	1 請願・陳情の付託先委員会について 2 令和8年第4回定例会の日程について 3 その他

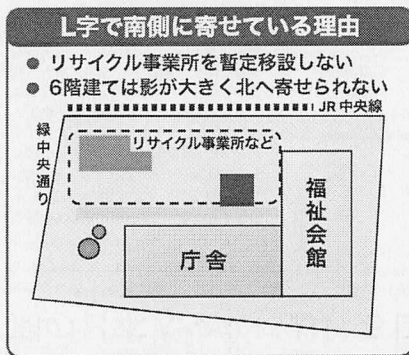
※ 必要に応じて、議会運営委員会、会派代表者会議を開催する。

設計前提はすでに変化、複雑なL字型は不要

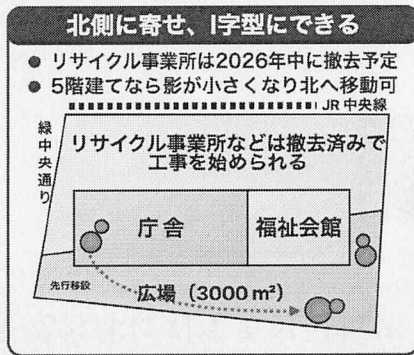
- リサイクル事業所は撤去予定、5階建てなら影が小さく北へ移動可



L字型で南に寄せていた前提は、すでに変わっている



前提が変化



現在の条件なら、複雑なL字型にする必要はない

庁舎と福祉会館の建設を考える会のブログ
小金井市の新庁舎等建設について私たちの提案（2020年10月）を修正
<https://ameblo.jp/kogaaneityousyanokai/entry-12838608314.html>

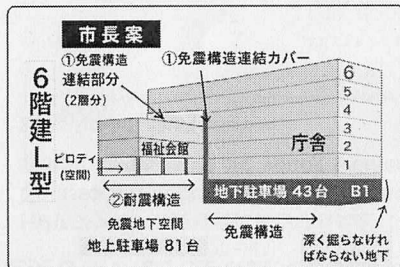


- 1 -

同時竣工なら庁舎と福祉会館を一体構造にできコスト削減

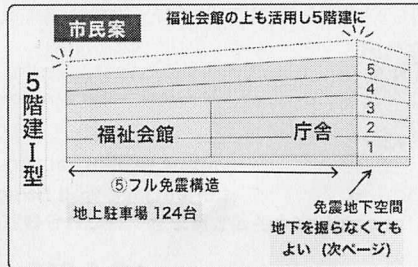
- 耐震構造の上に免震構造を載せる複雑な構造が不要になる

以前：福祉会館を先に竣工予定だったので



耐震構造の福祉会館と
免震構造の庁舎を連結
複数の構造で建設費増

現在：同時竣工になったので



初めから一体構造にできる
複雑な連結構造が不要
単純な構造で建設費を削減

- 2 -

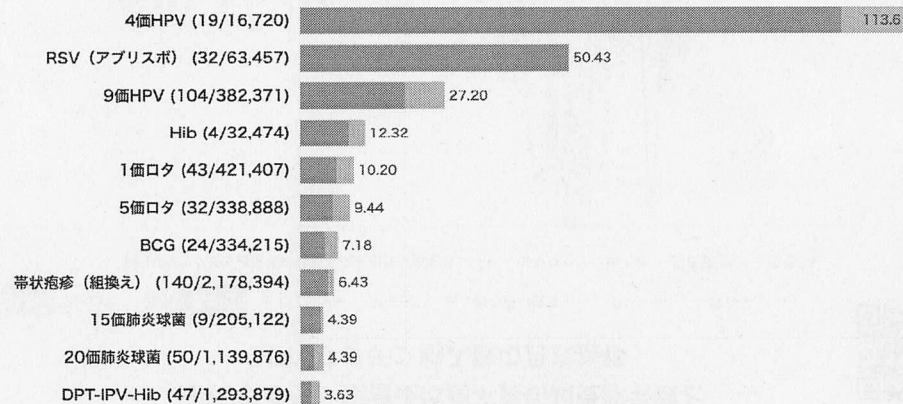
ワクチン別 重篤な副反応疑い報告頻度

ワクチン別 重篤な副反応疑い報告頻度（接種可能なべ人数10万当たり）



集計期間：2025-04-01～2025-09-30

■ 製造販売業者からの報告（全件重篤） ■ 医療機関からの報告（うち重篤）

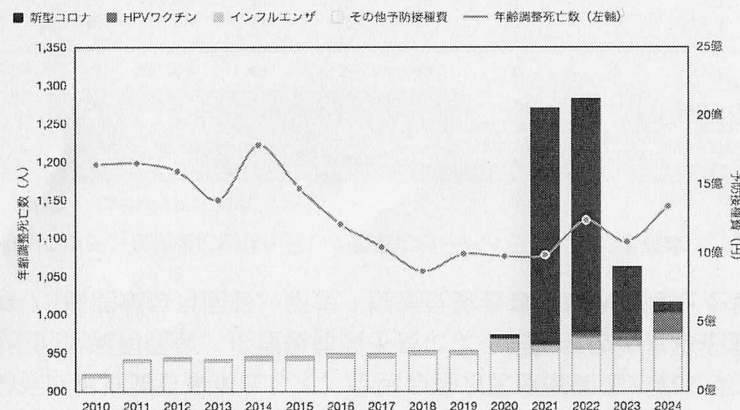


- 3 -

小金井市で予防接種費が増加、HPVワクチンの占める割合増える

- 2021年コロナワクチン接種開始と共に死亡数が増加、2022年に急上昇
- （元々、高齢化の影響を排除すると、2020年まで減少傾向だった）
- グラフは市民課提供の2010年からの住民基本台帳(22万レコード)から作成
- 接種費は3億円からコロナ過で20億円、その後でも5億円前後と高止まり

小金井市 年齢調整死亡数・予防接種費（ワクチン種別）推移（2010～2024年）



出典：令和8年第1回定例会 藤川議員一般質問資料 令和8年2月26日（市民部市民課 福祉保健課提供）

- 4 -

名古屋スタディで症状増加無しと結論も、病院受診は13項目増加

- 安全性示す論文として扱われるが、病院受診では24項目中13項目有意に増加
- Abstract(概要)でも「接種は病院受診の年齢調整オッズ比の上昇」と明記
- 本文の Table.6 では「簡単な計算ができなくなった」4.95倍(有意)
「簡単な漢字が思い出せなくなった」6.15倍(有意)
- 推奨している人達も論文を読んでいないから知らない

HPVワクチンと接種後に報告された症状との関連は認められない：名古屋スタディの結果
No association between HPV vaccine and reported post-vaccination symptoms in Japanese young women: Results of the Nagoya study

Sadao Suzuki*, Akihiro Hosono
鈴木貞夫
Department of Public Health, Graduate School of Medical Sciences, Nagoya City University, 1-Kawasumi, Mizuho-cho, Mizuho-ku, Nagoya 466-8601, Japan

ARTICLE INFO

Keywords:
Human papilloma virus vaccine
Post-vaccination symptom
Population based epidemiological study
Questionnaire

ABSTRACT

Nagoya City introduced free HPV vaccination in 2010 and in April 2013 the Ministry of Health, Labour and Welfare included the HPV vaccine in the National Immunization Program. However, in June 2013, the Ministry suspended proactive recommendation of the vaccine after unconfirmed reports of adverse events. To investigate any potential association between the vaccine and reported symptoms, Nagoya City conducted a questionnaire-based survey.

「24種類の報告されたHPVワクチン接種後症状で有意な発生頻度の上昇は認められなかった」とあるが次の一文

「接種は病院受診の年齢調整オッズ比の上昇と関連していた。月経過多、月経不順、重度の頭痛、慢性的・持続的な月経過多」を無視している

接種後の自己抗体増加を示し証拠とまで記載の厚労省研究班論文

- 副作用を訴えた接種55人、比接種57人の自己抗体を調査、有意に増加
- 痛みや眼の調節に関係する受容体への自己抗体で症状に影響の可能性

ヒトパピローマウイルスワクチンによる予防接種後、思春期の日本人少女における自律神経受容体に対する自己抗体

秋代 ひなほ 1,2,3, 主一 遼田 1 **, カルメン・シェイベンボーゲン 3,5,4, ハラルド・ハイデケ 5,5, カイ・シュルツェ＝フォルスター 5,5, ジュリエン・ユンカー 5, ガブリエラ・リーメカステン 5,6,6, ラルフ・デヘンド 8, ドラスカ・ドラグン 9, イェアグ・シューンフェルド 10

信州大学病院、難治疾患センター1名

2 信州大学医学部神経学・リウマチ学

3 ドイツ医学免疫学研究所医学部3学科

ベルリン・ブランデンブルク再生治療センター(BCRT)、ドイツ

5 セルトレンド株式会社、ドイツ

6 ドイツ、シュレシヴィヒ＝ホルシュタイン大学リウマチ学

7 実験・臨床研究センター、チャリテ・ユニバーシティ・アンブリテ・ベルリン、ドイツ

8 ヘリオス・クリニック、ドイツ、心臓病学および腎臓学部

9 ドイツ、ベルリン、慈善・大学、腎臓・集中治療医学部門

イスラエル、シバ医療センター、ザパルドウィツ・オート免疫疾患センター10が所

Abstract (概要)

日本では、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種後に異常な症状を訴える思春期の少女が多く、これらの症状は、整形外過剰、慢性局所疼痛症候群(CRPS)、認知機能障害(HPV)によるワクチン接種の悪影響と見なされている。しかし、HPVワクチン接種とこれらの有害作用との間に因果関係は示されていない。本研究では、HPVワクチン接種後に副作用を訴えた少女の血清中に存在する多様なGタンパク質結合受容体に対する自己抗体を調べた。HPVワクチン接種を受けた55人の少女と、HPV免疫のない57人の少女が研究に登録された。アドレナリン受容体に対する自己抗体血清レベルは、対照群の対照群と比較して、アドレナリン受容体α1、α2、β1およびβ2、ムスカリンAセチルコリン受容体1、2、3、4、5、およびエンDセリン受容体Aに対して著しく上昇した。これらの自己抗体の血清レベルは、病気の経過とともに低下する傾向があったが、これらの自己抗体の臨床的意味と血清レベルの上昇との間には統計的に有意な関連は見られなかった。この初期研究は、ワクチン接種後の異常な自己免疫が、HPVワクチン接種後の特有の症状の発現において重要な役割を果たすことを示す証拠を示している。

HPVワクチンの安全性に関するフォローアップ研究

- 厚生労働行政推進調査事業として、全国の協力医療機関を対象に実施
- 目的: 積極的勧奨再開後、接種後体調不良による受診者数の推移把握
- 95機関中75機関が毎月回答、新規・継続受診者数や納入数などを集計

HPVワクチン接種後に症状を呈した患者のサーベイランス受診患者数 (2024年度)

・速報値 (2026年7月1日時点)

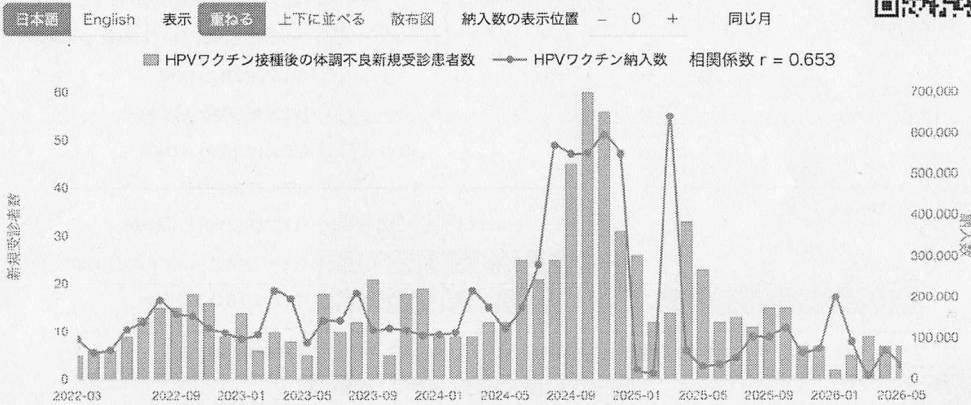
(人)	回答施設数	ワクチン納入数 (*1)	合計受診患者数 (新規+継続)	新規受診患者数	継続受診患者数 (*2)	1週間以内に発症した患者数 (*3)	1週間以降、1ヶ月以内に発症した患者数 (*3)	1ヶ月以降に発症した患者数 (*3)	発症時期不明
2022年3月分	63	99,003	47	5	42	1	2	1	1
2024年度									
4月分	58	175,445	43	12	31	7	2	3	0
5月分	57	123,566	40	12	28	8	2	2	0
6月分	59	176,133	68	25	43	20	5	0	0
7月分	59	280,804	64	21	43	13	6	1	1
8月分	60	571,426	65	25	40	17	6	2	0
9月分	62	550,013	87	45	42	36	7	0	0
10月分	69	552,795	115	60	55	36	18	7	0
11月分	67	597,151	116	56	60	34	13	8	1
12月分	66	550,555	98	31	67	16	5	10	0
1月分	64	25,010	85	26	59	10	6	8	1
2月分	66	15,038	71	12	59	5	4	3	0
3月分	61	640,306	86	14	71	11	0	2	1

※1 9価ワクチンを含む ※2 1ヶ月内の複数回受診は1人とカウント ※3 新規患者のみ対象

HPVワクチンの安全性に関するフォローアップ研究グラフ化(1)

- 見事に相関するワクチン納入数と新規受診者数

HPVワクチン接種後体調不良新規受診者数と HPVワクチン納入数の月次推移



出典

厚生労働省「HPVワクチンの安全性に関するフォローアップ研究」(第112回副反応検討部会 資料3-3、2026年7月24日)
<https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001727329.pdf>

HPVワクチンの安全性に関するフォローアップ研究グラフ化(2)

- 新規受診者累積の10分の1が健康被害救済制度による認定を受けている

HPVワクチン接種後の体調不良新規受診者数の累積と 健康被害認定・子宮頸癌患者・死者との比較



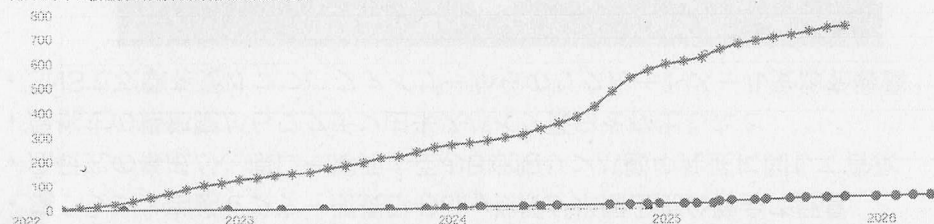
日本語 English 15歳以上 20歳未満 25歳未満 30歳未満 35歳未満 40歳未満 45歳未満 50歳未満 60歳未満 70歳未満 80歳未満

累積の起点 2011年7月(最初の認定) 2022年3月(受診者系列の開始)

表示項目

- 体調不良を主訴として協力医療機関を受診した患者(新規・累積)
- HPVワクチン健康被害認定者・20歳未満(累積)
- 子宮頸癌患者・20歳未満(累積)
- 子宮頸癌死亡者・20歳未満(累積)
- 女性の自殺・20歳未満(月次・累積)
- 女性の全死因・20歳未満(月次・累積)

HPVワクチン接種後の体調不良新規受診者数の累積



- 9 -

HPVワクチンの安全性に関するフォローアップ研究グラフ化(3)

- 20歳未満の新規受診者や健康被害認定者は、子宮頸癌患者より圧倒的に多い
- 30歳以上が多い子宮頸癌、20歳未満の膨大なワクチン後遺症患者、倫理は?

HPVワクチン接種後の体調不良新規受診者数の累積と 健康被害認定・子宮頸癌患者・死者との比較



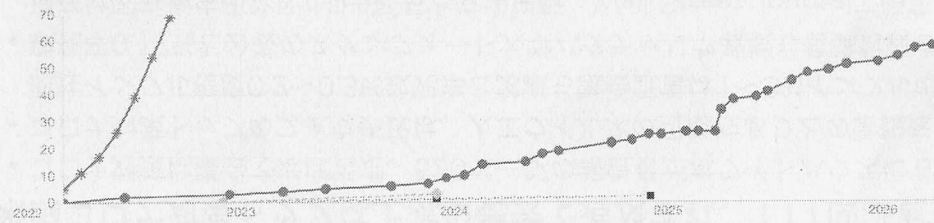
日本語 English 15歳以上 20歳未満 25歳未満 30歳未満 35歳未満 40歳未満 45歳未満 50歳未満 60歳未満 70歳未満 80歳未満

累積の起点 2011年7月(最初の認定) 2022年3月(受診者系列の開始)

表示項目

- 体調不良を主訴として協力医療機関を受診した患者(新規・累積)
- HPVワクチン健康被害認定者・20歳未満(累積)
- 子宮頸癌患者・20歳未満(累積)
- 子宮頸癌死亡者・20歳未満(累積)
- 女性の自殺・20歳未満(月次・累積)
- 女性の全死因・20歳未満(月次・累積)

HPVワクチン健康被害認定者数の累積



- 10 -

健康被害者の補償は因果関係を厚労大臣が認めたときのみ支給

- 他の原因によるものと考えられる合理性が無いことが一つの前提[5]
- 「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず」というのはワクチン成分が残っていることなど厳密な証明は不要という意味。強調されるから誤解が多い
- 予防接種被害者健康手帳には「予防接種を受けたことにより疾病にかかり、又は障害の状態となったものであることを証明」とまで書いてある
- しかし厚労省は意図的に誤解を誘導する国会答弁などをしているように見える

健康被害救済制度の考え方

- 法に基づく予防接種は社会防衛上行われる重要な予防的措置であり、極めて稀ではあるが不可避的に健康被害が起こりうるという特性があるにも関わらずあえて実施しなければならないということに鑑み、健康被害を受けた者に対して特別な配慮をするために設けられた制度である。
- 本制度による給付を受けるためには、疾病・障害認定審査会の審査を経る必要がある。同分科会においては、申請資料に基づき、個々の事例ごとに
 - 症状の発生が医学的な合理性を有すること
 - 時間的密接性があること
 - 他の原因によるものと考えられる合理性がないこと
 等について、医学的見地等から慎重な検討が行われている。
- その上で、認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われている。

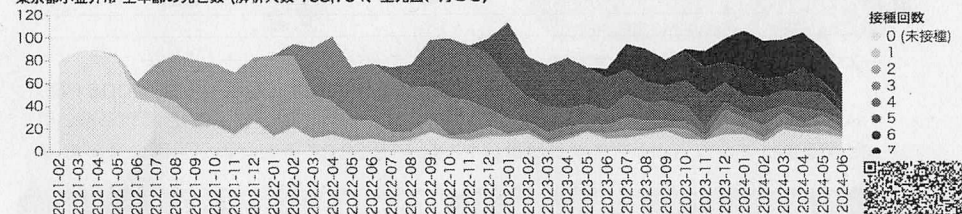


- 11 -

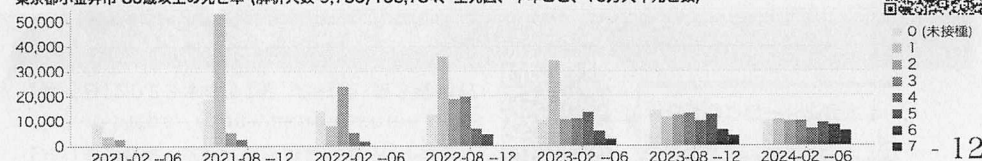
小金井市でのコロナワクチン接種歴別の死亡数と死亡率

- 市民課と健康課から提出いただいたデータから作成、有難うございます
- ワクチン接種回数の多い方の死亡数が多く、人年法死亡率でも高い時期あり
- 2026年8月～12月では、未接種より、1回～3回接種の死亡率が高い
- 接種してすぐ亡くなった方のVRS(ワクチン報告システム)の入力不備があると接種の多い方の死亡率が本来は低いのに高い結果となるのでは無いか?

東京都小金井市 全年齢の死亡数(解析人数 138,784、全死因、月ごと)



東京都小金井市 80歳以上の死亡率(解析人数 9,730/138,784、全死因、半年ごと、10万人年死亡数)



- 12 -

米国コロナ対策トップは上院公聴会で追及され、111回証言拒否

- コロナ対策は議会ではほぼ否定、520ページの報告書がホワイトハウスにも掲載
- コロナ対策トップのファウチ氏は、人工ウイルスの可能性ありとの言説を封殺
悪性インフル程度0.2~0.3%致死率と認識も議会証言は1~3%インフルの10倍
- 致死率0.17%と公表のスタンフォード大学バタチャリヤ教授も言論封殺された
現在は国立衛生研究所(NIH)所長と立場逆転、Wall Street Journalで特集動画

Feb. 8, 2020 – Numbers today: 34,867/724. First USCit died in Wuhan. Much press about this and the cruise ships in Japan and Bayonne. Infections and quarantine of the Japan ship (61 so far, including some USCits. 10 people under quarantine from airport screening at the 11 airports. People on Japanese ship getting cabin fever with quarantine. People on Bayonne ship have all been released and the Chinese nationals on the ship are going home.

Tom Frieden called me this AM and we discussed various aspects of the outbreak. He and I are on the same page in thinking that this is acting like a bad influenza in its transmissibility and that the denominator is much greater than 34,867 (above) making the case fatality rate (CFR) more like 0.2-0.3 % rather than 2.0%.

https://www.paul.senate.gov/wp-content/uploads/2020/07/2020.07.24_Tony's-Diary-Package.pdf

2020年2月8日 - 本日の数字 : 34,867/724. 初めての米国市民が武漢で死亡。これに関する報道が多く、日本とパヨク船のクルーズ船についても。日本の船での感染と隔離 (これまでに61人、米国市民も一部含む)。11の空港での空港スクリーニングによる隔離中の人が10人。日本の船の人々は隔離で船内熱 (cabin fever) を起こしている。パヨクの船の人々は全員解放され、船に乗っていた中国国籍の人たちは帰国する。今朝トム・フリーデンから電話があり、アウトブレイクのさまざまな側面について話合った。彼と私は同じ考えで、これは伝播性の点で性質(たち)の悪いインフルエンザのように振る舞っており、分母が上記の34,867よりはるかに大きいため、症例致死率 (CFR) は2.0%ではなく0.2~0.3%程度になるだろうと思っている。



- 13 -

米上院で日本の元大臣のコロナワクチン接種後リンパ腫が言及

- ブラウン大学癌センター所長El-Deiry教授が米国上院公聴会で証言
- 癌研究の権威が、原口一博元大臣のB細胞リンパ腫の発症に関して言及
- 扁桃生の癌細胞からワクチン由来スパイク蛋白を検出したと
- SNSで攻撃を受けつつ、ファイザーからのリクルートメール受診を暴露



And shortly afterwards, I was contacted directly by former Japanese minister Kazuhiro Haraguchi, who reported developing a diffuse large B cell lymphoma that later metastasized to "his tonsil and biopsy. And then they found spike protein" その直後日本の元大臣から直接連絡を受けました。原口一博氏はびまん性大細胞型B細胞リンパ腫を発症し、その後扁桃に転移し生検を受けたと報告、そしてスパイク蛋白質が発見されました



- 14 -

【発行】HPVワクチン東京訴訟支援ネットワーク

<https://hvp-yakugai-shien.net/>

【発行日】2023年6月1日 資料用 第3版発行

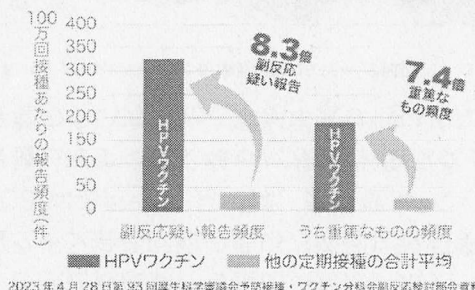


資料は抜粋。左のQRコードからダウンロードできます

HPVワクチンと副反応被害

他のワクチンと比べても高い副反応疑いの報告

◆ 厚労省の副反応検討部会 2023年4月28日資料によると HPV ワクチンの副反応疑い報告は計 3633 件 (約 1100 人に 1 人発生) うち重篤=入院相当以上が 2109 件 (約 1900 人に 1 人発生) にのぼっています。



2023年4月28日第93回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料より

これまでに約 400 万人が接種して...

副反応疑い報告 3633 人
(約 1100 人に 1 人)

うち重篤 2109 人
(約 1900 人に 1 人)

入院相当以上の深刻で重い症状

◆ HPV ワクチン副反応疑い報告の頻度は、他の定期接種 (12 種類) の平均値の 8.3 倍、うち重篤なもの頻度も 7.4 倍です。9 価ワクチンのシルガード9は、4 価ワクチンよりもさらに高い頻度で重篤副反応疑い報告が出ています。(同厚労省資料によると 2.0 倍)

複合的な副反応被害と、確立しない治療法

◆ 副反応の症状は多様で、ひどい頭痛、全身の疼痛、脱力、不随意運動、歩行障害、睡眠障害、月経障害、記憶障害、学習障害など、多様な症状が一人の患者に重層的にあらわれるものです。この重篤な副反応の治療法は確立していません。

症状が複雑で理解されにくい

○ 一人にいろいろな症状が重なって出ているよ

治療法がみつからない



◆ 国が全国に設けた協力医療機関には、「このワクチンに副反応なんてない」と、被害者を詐病扱いするような医師もあり、十分に機能していません。被害者を真摯に診てくれる数少ない病院を頼って1000キロ以上移動せざるを得ない被害者もたくさんいます。

○ 「協力」医療機関でも治療してもらえない。だれを頼ればいいんだろう??

令和8年6月15日発行

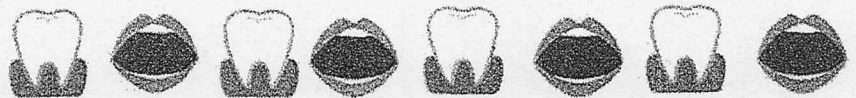
是 号

小金井市健康課

TEL042-321-1240

栄養ニュース

歯と口の健康



歯と口の健康週間とは？

6月4日から6月10日は歯と口の健康週間です。

歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着、早期発見及び早期治療のため、歯と口の健康に関する正しい知識の普及啓発を行い、歯だけでなく健康そのものの保持増進を目的としています。期間中は全国的に「歯と口の健康」にちなんだ様々な催しが実施されています。

小金井市では6月21日に小金井宮地楽器ホールにて「小金井市民の歯と口の健康2026」イベントを小金井歯科医師会主催で開催します。

規則正しい食習慣で歯の健康・体の健康を守りましょう！

規則正しい食習慣は歯の健康・体の健康に密接に関わっています。

通常、口内は中性に保たれており、食事をすると酸性に傾きます。酸性状態では歯の溶解が起こり一次的に虫歯になりやすい状態となりますが、食後1時間ほど経過すると中性に戻り再石灰化されます。口内では毎食ごとにこのサイクルが繰り返されているため、だらだら食べや間食を行うと口内は酸性のままとなり、虫歯になりやすくなります。規則正しい食習慣をおくることで虫歯になりやすい時間を短くし、歯の健康を守りましょう。

もちろん、規則正しい食習慣は歯の健康だけでなく体の健康にとっても効果的です。

特に朝食を毎朝おおむね決まった時間にとることで、体内時計を整えることができます。

さらには、血糖値の安定させるためにも規則正しい食習慣は重要です。

ぜひ、この機会に日ごろの食習慣を見直してみてもいいのではないでしょうか。

小金井野菜で簡単レシピとうもろこしのピカタ

市食育ホームページでは毎月「小金井野菜で簡単レシピ」を掲載しています。

今回はこの季節にぴったりの「とうもろこしのピカタ」をご紹介します！

新着レシピはこちら→→→→→→→→→→→→→→→→



材料 (2人分)

・とうもろこし	1本
・ピザ用チーズ	80g
・卵	2個
・小麦粉	大さじ2
・サラダ油	大さじ1
・バター	10g
・塩、こしょう	少々



つくり方

①とうもろこしは包丁などで芯から実をはずしてボウルに入れ、小麦粉をまぶしておく。

②①のボウルにチーズとよく溶いた卵を加え、塩、こしょうしてさっくりと混ぜる。

③熱したフライパンにサラダ油をしき、バターを溶かす。スプーンで②を食べやすい大きさに広げ両面をじっくり焼く。

④両面に焼き目がついたら皿に盛りつけ、お好みでケチャップ、マスタードを添える。

米軍ニュースとは



小金井市健康課では令和8年度から栄養
ニュースを発行することとなりました！

食育や健康にまつわること、小金井市食育ホームページのレシピ、ミニコラムなどを発信していきます。

記念すべき第1号は、「小金井市民の歯と口の健康2026」イベントにあわせて配布を行っています。

今後、市内公共施設や保健センターにて、各季節ごとの配布を予定しています。

食事は健康、団らんなどさまざまな側面があり、日々の生活と密接に関わっています。

市民の皆様の健康の一助となるような情報をお届けします。

ぜひお手に取ってご覧ください。

今後の栄養ニュースもお楽しみに！！！！

新着情報はこちら→→→→→



国民健康制度に関する各資料

※「議会と自治体」2026 年 7 月臨時号「国保改善運動の焦点」から抜粋し作成

①国保と他の保険との比較

表3 各保険者の比較(2023年度)

	市町村国保	協会けんぽ	組合健保	共済組合	後期高齢者医療制度
保険者数 (2024年3月末)	1,716	1	1,380	85	47
加入者数 (2024年3月末)	2,309万人 (1,590万世帯)	3,954万人 〔被保険者2,521万人 被扶養者1,433万人〕	2,803万人 〔被保険者1,668万人 被扶養者1,135万人〕	979万人 〔被保険者576万人 被扶養者402万人〕	1,978万人
加入者平均年齢 (2023年度9月末)	54.0歳	38.9歳	36.1歳	35.3歳	82.7歳
65～74歳の割合 (2023年度)	43.8%	8.2%	3.6%	3.5%	1.3%
加入者一人当たり 医療費(2023年度)	41.7万円	21.0万円	19.3万円	20.0万円	96.4万円
加入者一人当たり 平均所得(2023年度)	99万円 〔一世帯当たり145万円〕	182万円 〔一世帯当たり286万円〕	253万円 〔一世帯当たり425万円〕	244万円 〔一世帯当たり413万円〕	94万円
加入者一人当たり 平均保険料(2023年度) 〔事業主負担込〕	9.3万円 〔一世帯当たり 13.6万円〕	13.0万円(26.0万円) 〔被保険者一人当たり 20.5万円(40.9万円)〕	14.4万円(31.4万円) 〔被保険者一人当たり 24.1万円(52.8万円)〕	14.8万円(29.5万円) 〔被保険者一人当たり 25.0万円(50.0万円)〕	7.9万円
保険料負担率	9.3%	7.2%	5.7%	6.1%	8.4%

出所)厚生労働省「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議」(2026年3月11日)への保険局国民健康保険課の説明資料から作成

②国保加入者の所得の推移

③法定外繰入金に関する資料

表5 法定外繰り入れの2つの区分

表1 市町村国保の保険料、加入世帯の平均所得の推移

年度	1世帯当たり 保険料(円)	1人当たり 保険料(円)	加入世帯の 平均所得(万円)
1985	112,640	43,357	186.8
1990	144,933	62,092	240.5
1991	148,616	65,284	276.5
1995	148,910	70,620	230.8
2000	157,005	79,123	197.5
2005	152,659	80,352	168.7
2010	154,872	88,578	145.1
2015	152,352	93,203	139.6
2016	152,930	94,140	138.8
2017	151,767	95,230	136.1
2018	149,620	96,289	136.7
2019	149,623	96,829	133.5
2020	147,593	96,625	136.0
2021	146,899	97,179	140.4
2022	147,905	99,378	142.5
2023	147,926	100,997	145.4

出所)政府資料より党政策委員会が作成

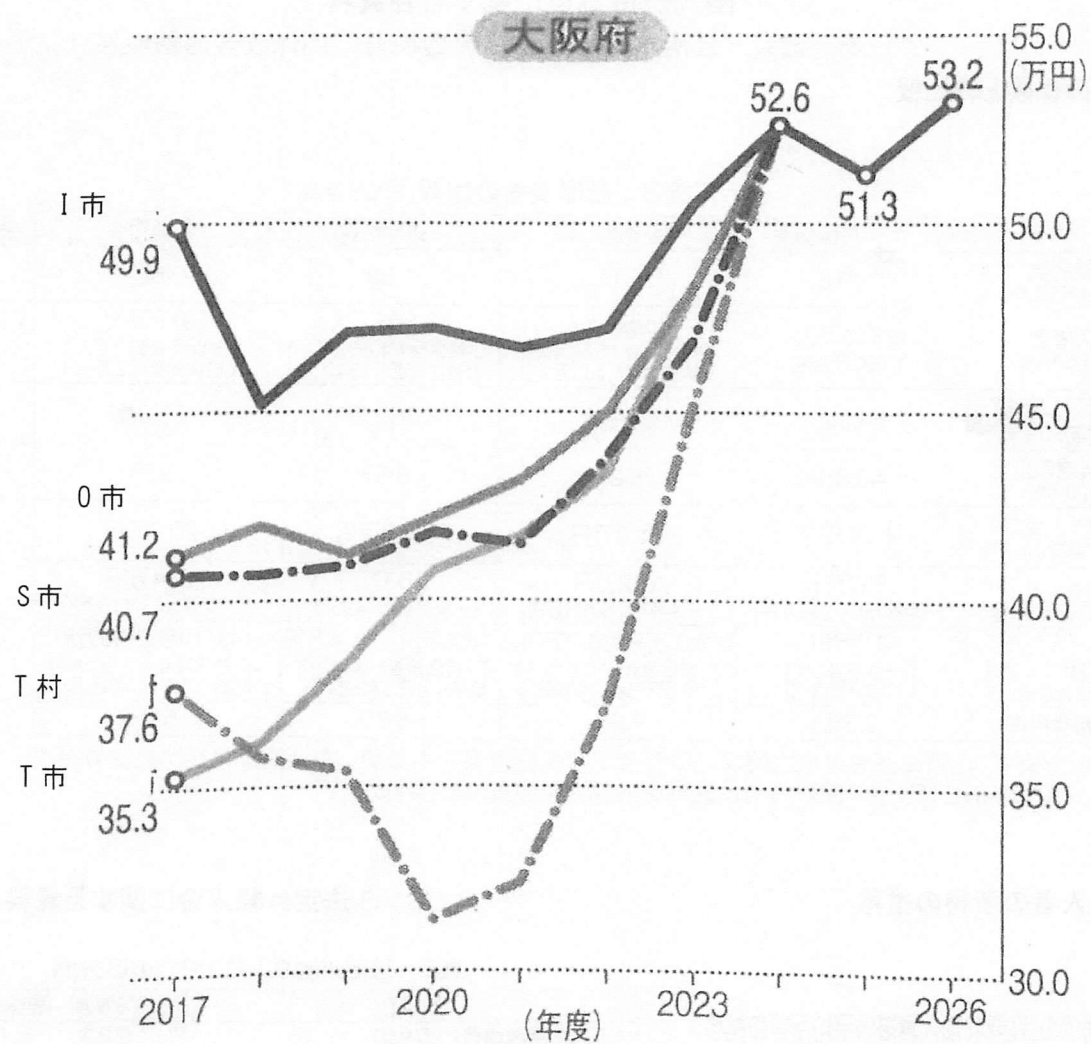
分類		2015年度	対2014年度
決算補填等目的の法定外繰入	①決算補填目的のもの	293	▲1,282
	保険料収納不足のため	27	▲1,314
	医療費の増加	258	67
	後期高齢者支援金等	8	▲35
	高額療養費貸付金	0	0
	②保険者の政策によるもの	2,560	1,267
	保険料(税)の負担緩和を図るため	2,498	1,267
	地方単独の保険料(税)の軽減額	51	▲1
	任意給付費に充てるため	11	1
	③過年度の赤字によるもの	182	▲10
決算補填等目的以外の法定外繰入	累積赤字補填のため	181	▲2
	公債費・借入金利息	1	▲8
	小計	3,034	▲25
	保険料(税)の減免額に充てるため	130	▲4
	地方単独事業の医療給付費波及増等	300	▲20
	保健事業費に充てるため	173	17
	直営診療施設に充てるため	4	▲0
	納税報償金(納付組織交付金)等	0	0
	基金積立	32	6
	返済金	57	20
合計	その他	126	21
	小計	822	39
合計		3,856	12

*国民健康保険の事業実施状況報告(2017年2月28日公表の2015年度決算速報値)から
出所)厚生労働省「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議」(2018年1月30日)、「国民健康保険分科会」への保険局国民健康保険課の説明資料「法定外繰入の状況(平成27年度決算)」を基に作成

国保運営方針に基づき、計画的に削減・解消すべき赤字

「赤字」と見なさない繰り入れ

④大阪府の各自治体の国民健康保険料(税)の推移



※給与年収400万円の片働き夫婦(40歳未満)子2人(小学生)の4人世帯のモデルで計算した場合の国保料(税)の推移。

会計年度任用職員（月給制）の在職年数等について

(単位：人)

課名	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計
企画政策課	1	0	0	0	0	1
財政課	0	0	0	0	0	0
広報秘書課	1	1	1	2	0	5
情報システム課	0	0	0	0	0	0
総務課	0	1	0	2	1	4
地域安全課	0	0	0	0	0	0
職員課	0	1	0	3	2	6
管財課	2	1	1	4	0	8
市民課	0	4	1	3	0	8
コミュニティ文化課	0	1	0	0	0	1
経済課	0	2	0	3	0	5
保険年金課	1	1	0	2	3	7
市民税課	1	2	0	1	0	4
資産税課	0	2	1	0	1	4
納税課	2	3	1	1	2	9
環境政策課	2	0	0	0	0	2
ごみ対策課	0	0	2	0	0	2
下水道課	1	1	0	0	0	2
地域福祉課	1	4	3	1	2	11
自立生活支援課	5	0	0	2	0	7
介護福祉課	2	1	6	1	5	15
健康課	1	1	1	1	0	4
子育て支援課	3	1	1	0	1	6
保育課	2	1	0	1	1	5
保育園	14	11	10	12	4	51
児童青少年課	4	4	1	12	1	22
こども家庭センター	1	3	0	3	2	9
都市計画課	2	0	1	0	2	5
まちづくり推進課	0	0	1	1	0	2
道路管理課	2	1	1	1	1	6
建築営繕課	0	0	0	2	0	2
交通対策課	0	0	0	1	1	2
区画整理課	0	0	0	1	0	1
会計課	1	0	0	1	0	2
庶務課	0	0	1	0	1	2
学務課	3	0	0	0	0	3
指導室	4	5	1	2	2	14
小学校及び中学校	13	27	23	10	20	93
生涯学習課	0	3	2	0	0	5
図書館	0	4	5	5	4	18
公民館	0	1	0	0	2	3
議会事務局	0	0	0	1	0	1
選挙管理委員会事務局	0	1	0	0	0	1
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0
合計	69	88	64	79	58	358

※ 令和8年4月1日現在

※ 更新上限回数満了後に同一職種で再度任用された場合は、1年目として計上している。

職場における周知にご協力ください！

1. 不登校対策に関する取組や相談窓口

✓ 国においては、不登校児童生徒が学びたいと思った時に学ぶことができるよう、個々の状況に応じた多様な学びの場の確保に向けた取組を推進しています(別添参照)

✓ また、お子さんが不登校になった保護者の方や、様々な悩みを抱えるお子さん自身が相談できる窓口設置を各地域に促し、専門家による相談支援やその他の支援に関する情報が届くよう取り組んでいます。

✓ 各企業においても、社員の皆さんがお子さんの不登校を理由に休業・離職に追い込まれる状況を防ぐ観点から、社員の皆さんに対して、不登校対策に関する行政の取組や相談窓口に関する情報の周知にご協力をお願いします。



不登校に関する
地元の相談窓口

2. 障害のあるお子さんや医療的ケアを必要とするお子さんについても、介護休業・休暇制度等を利用可能な場合があります

✓ 育児・介護休業法に基づく介護休業・介護休暇等の制度は、「常時介護を必要とする状態」にある「対象家族」を介護する場合に利用することができ、「対象家族」には父母や配偶者、祖父母の他、子も含まれます。

✓ 不登校児童生徒が育児・介護休業法における「常時介護を必要とする状態」に該当し、保護者の「対象家族」である場合には、介護休業・休暇制度等が利用可能です。

※ 「常時介護を必要とする状態」や介護休業制度等の詳細は、厚生労働省HPをご覧ください

<不登校を理由とした休業制度を導入している企業の例>

【共同印刷株式会社】(東京都・製造業)

共同印刷株式会社では、2023年1月より「ライフサポート休業制度」を導入しています。

この制度では、子どもの不登校や不妊治療を理由とした休業を最長2年間、短時間勤務は最長3年間まで利用することを可能にするものです。

柔軟な働き方を可能にする仕組みとして、時差出勤やテレワークといった既存の制度に加え、それでは対応しきれない状況に直面した場合の「セーフティネット」として活用を促しています。

こうした取組を通じて、様々な事情を抱えて働く社員同士、互いに支え合おうというメッセージを発信することにもつながると考えています。

事業主・労働者の皆さまへ 不登校の現状をご存じですか？

1. 不登校の現状と対策

✓ 「不登校」とは

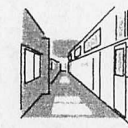
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいは、したくともできない状況にあるために、年間30日以上欠席した児童生徒。

✓ 不登校児童生徒数の推移

小・中学校の不登校児童生徒数は12年連続で増加し、令和6年度は、約35万4千人と過去最多。

※小学校では、約44人に1人、中学校では、約15人に1人にいる計算。

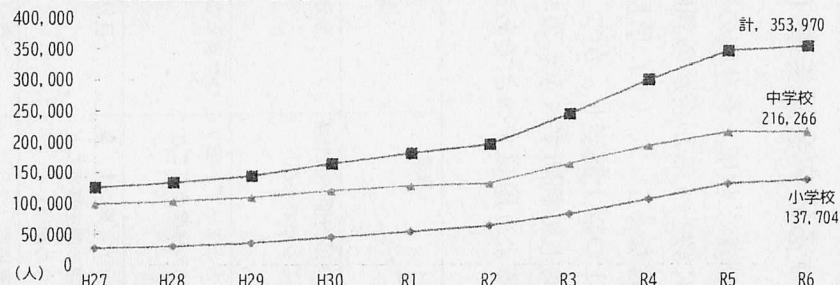
中学校ではクラスに2～3人程度は不登校生徒が存在。



✓ 国の取組

不登校対策は、各学校及び設置者である教育委員会等が中心となって取組を進めるとともに、国におきましても、令和5年に取りまとめた「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」(COCOLOプラン)等に基づき、関係省庁が連携を図りながら、様々な支援に取り組んでいるところです(別添参照)

不登校児童生徒数の推移



2. 不登校対策は、社会全体が連携して取り組むことが必要です

✓ 不登校対策については、引き続き、各学校や教育委員会、地域等が主体となって取り組んでまいりますが、生活リズムの不調や友人関係のトラブルなど様々な理由・背景により、子供が不登校となった場合、特に小学校低学年では、保護者が自宅で子供を見守らざるを得なくなるなど、保護者の就業にも影響が生じ得ることに留意が必要です。

✓ また、不登校が続くことで、保護者が離職や休職をせざるを得ない状況に追い込まれてしまうといったケースも指摘されています。



文部科学省

MINISTRY OF EDUCATION,
CULTURE, SPORTS,
SCIENCE AND TECHNOLOGY-JAPAN



厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』
の見直しに関する研究会報告書 (2025年1月) 抜粋

いわゆるひきこもり、不登校の状態にある対象家族が「常時介護を必要とする状態」に該当するか否かの判断に当たっては、こうした状態にある事実そのものではなく、「(1) 項目①～⑫のうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められる」という基準に照らして判断すべきものであり、個々の事情に応じた適切な制度運用がなされるよう留意すべきである。

項目 \ 状態	1 (注2)	2 (注3)	3
① 座位保持 (10分間一人で座っていることができる)	自分で可	支えてもらえればできる (注4)	できない
② 歩行 (立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる)	つかまらないでできる	何かにつかまればできる	できない
③ 移乗 (ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作)	自分で可	一部介助、見守り等が必要	全面的介助が必要
④ 水分・食事摂取 (注5)	自分で可	一部介助、見守り等が必要	全面的介助が必要
⑤ 排泄	自分で可	一部介助、見守り等が必要	全面的介助が必要
⑥ 衣類の着脱	自分で可	一部介助、見守り等が必要	全面的介助が必要
⑦ 意思の伝達	できる	ときどきできない	できない
⑧ 外出すると戻れないことや、危険回避ができないことがある (注6)	ない	ときどきある	ほとんど毎回ある
⑨ 物を壊したり衣類を破くことがある	ない	ときどきある	ほとんど毎日ある (注7)
⑩ 周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れなど日常生活に支障を来すほどの認知・行動上の課題がある (注8)	ない	ときどきある	ほとんど毎日ある
⑪ 医薬品又は医療機器の使用・管理	自分で可	一部介助、見守り等が必要	全面的介助が必要
⑫ 日常の意思決定 (注9)	できる	本人に関する重要な意思決定はできない (注10)	ほとんどできない

子宮頸がんワクチン予防接種及び男性HPVワクチン予防接種実施状況

1 子宮頸^{けい}がんワクチン予防接種

(1) 対象者

ア 小学6年生から高校1年生相当までの女子（定期接種）

イ 平成9年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの女性（キャッチアップ接種）

(2) 接種者数

年度	接種者数	キャッチアップ接種者数（再掲）
令和3年度	536人	
令和4年度	1,460人	795人
令和5年度	1,851人	1,019人
令和6年度	5,036人	4,200人
令和7年度	1,406人	679人

2 男性HPVワクチン予防接種

(1) 対象者

小学6年生から高校1年生相当までの男子

(2) 接種者数

年度	接種者数
令和6年度	120人
令和7年度	150人

3 HPVワクチン予防接種後副反応疑い報告件数

令和3年度から令和7年度まで 2件

子宮がん検診の受診状況（過去5年間）

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
対象者		31,840人	31,128人	31,975人	32,108人	26,646人
受診者		2,541人	2,278人	2,250人	2,352人	2,323人
受診率		15.9%	15.5%	14.2%	14.3%	17.5%
要精検	対象者	67人	58人	57人	38人	51人
	対象率	2.6%	2.5%	2.5%	1.6%	2.2%
がん	発見者	0人	0人	1人	0人	－
	発見率	0.0%	0.0%	0.04%	0.0%	－

※要精密検査対象率及びがん発見率は、受診者に対するそれぞれの割合

※受診率＝（前年度受診者＋当該年度受診者）÷当該年度対象者

小金井市長 白井 亨 様

要望書

2026（令和8）年7月28日

ブンブンアクション小金井 共同代表 ()

国分寺崖線の自然を守る会 代表

都市計画道路を考える小金井市民の会 共同代表

はけの自然と文化をまもる会 代表

野川ほたる村 村長

平素より、市政にご尽力を賜りまして、御礼申し上げます。

市長は、2025（令和7）令和7年10月22日に、東京都知事小池百合子知事に対し、「都市計画道路に係る要望」を提出しました。小金井市都市計画道路3・4・11号線について「道路整備の必要性は否めません」と結論したこの要望の内容については、これに先立って行われた市民説明会や意見交換会でも市民からの異論が多数提示されましたが、その後も、一般財団法人国土計画協会会長で東京大学・豊橋技術大学名誉教授の大西隆氏により専門的見地から当該道路の必要性について否定的見解が提示されるなどしています。このような動きを受け、私たちは当該要望をあらためて精査し、いくつかの懸念や疑問を抱きました。

まず、「都市計画道路に係わる要望」には、小金井市都市計画道路3・4・11号線について、1(1)結論として、当該路線の「道路整備の必要性は否めません」とあります。この「必要性は否めません」という表現は曖昧で、市としてどのような態度を都に表明しているのか、都の側からしても理解困難なのではないかと私たちは憂慮しています。

また、「都市計画道路に係わる要望」1(2)要望事項には、「自然環境等への影響は否定できないため、東京都生物多様性地域戦略も踏まえ、具体的な影響と対策を明らかにしてください」とあります。しかし、東京都生物多様性地域戦略は大部で項目也多岐に渡っており、市として当該戦略のどのような点を踏まえるべきだと考えているのかが示されておられません。この点が明らかにされない限り、都に対する市の要望の具体的な内容を把握することができません。

最後になりますが、東京都に対する要望を提出した後、この要望に対する東京都側の動きがどのようなものかが市民には伝わってきません。提出後の動きを説明することも、市の代表として都に要望を出した市長の責任に含まれると私たちは考えます。

回答は8月21日（金）までに文書の形式でお願いいたします。

1. 「必要性は否めない」という表現を説明してください。とりわけ、市長はこの道路整備に「賛成」か、「反対」か、「条件付き賛成(消極的賛成)」かを明確にしてください。もし条件付き賛成ならば、その条件を明確に、且つ、市民が客観的に判断し得るよう具体的に示して下さい

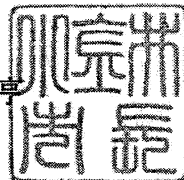
2. 東京都に、「具体的な影響と対策を明らかにする」ことを要望する上で、東京都生物多様性地域戦略のどの項目を踏まえて欲しいと考えているのかを明らかにしてください。

3. 市長はこの要望を都に提出した後、要望の実現のためのフォローアップや働きかけをこれまでどのように行ってきたのか、また今後行う予定なのか、説明してください。

小都都発第44号
令和8年8月19日

ブンブンアクション小金井 共同代表
国分寺崖線の自然を守る会 代表 様
都市計画道路を考える小金井市民の会 共同代表 様
はけの自然と文化をまもる会 代表 様
野川ほたる村 村長 様

小金井市長 白井 享



要望書の回答について

平素より、本市の都市計画行政に御理解、御協力を賜り、心より御礼申し上げます。
令和8年7月28日付け「要望書」でいただいた3点について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 「必要性は否めない」という表現を説明してください。とりわけ、市長はこの道路整備に「賛成」か、「反対」か、「条件付き賛成（消極的賛成）」かを明確にしてください。もし条件付き賛成ならば、その条件を明確に、且つ、市民が客観的に判断し得るよう具体的に示して下さい。

(回答)

都市計画道路3・4・11号線の整備に当たっては、国分寺崖線（はけ）、野川、武蔵野公園における三位一体の豊かな自然環境や地域に生息する動植物への影響が懸念されております。

一方で、令和8年7月28日に熊本県で最大震度7を観測する強い地震がありました。本市においても首都直下型地震の発生リスクが高まる中、本路線は市民の生命・財産を守るための防災インフラとして重要な役割を担うものです。また、交通ネットワークの形成や生活道路への通過交通の流入抑制による地域の安全性向上など、多面的な効果が期待されることから、整備の必要性は否めないと考えております。

以上のことから、本事業については必要性を認める一方で、自然環境への影響を十分に考慮する必要があることから、消極的な賛成と考えております。

なお、現時点で具体的な条件を付すものではありませんが、事業の実施に当たっては、自然環境への影響を可能な限り低減できるよう、環境保全の観点から事業課題について十分精査を行うことを要望しております。

- 2 東京都に、「具体的な影響と対策を明らかにする」ことを要望する上で、東京都生物多様性地域戦略のどの項目を踏まえて欲しいと考えているのかを明らかにしてください。

(回答)

東京都生物多様性地域戦略については、3つの基本戦略はいずれも重要な項目であると認識しております。

その中でも、都市計画道路3・4・11号線の整備に伴う自然環境や生物多様性への影響を考慮する観点から、特に基本戦略1「生物多様性の保全と回復を進め、東京の豊かな自然を後世につなぐ」を踏まえていただきたいと考えております。

国分寺崖線（はけ）、野川、武蔵野公園に代表される豊かな自然環境やそこに生息・生育する動植物への影響について、具体的な影響を把握するとともに、保全・回復に向けた対策を検討していただきたいと考えております。

- 3 市長はこの要望を都に提出した後、要望の実現のためのフォローアップや働きかけをこれまでどのように行ってきたのか、また今後行う予定なのか、説明してください。

(回答)

市としては、東京都に対し「性急な進捗は望まず、まずは事業課題を十分精査してほしい」と要望しました。その要望を踏まえ、現在、東京都においては、環境対策を含めた検討を概略設計の中で進めているものと認識しております。

今後は、概略設計が出てきた段階で、施工方法を含めた自然環境への影響とその対策が明らかになっていくことから、地元自治体として、自然環境ができる限り守られるように、その妥当性を庁内環境部門とも連携して調査研究していく予定でございます。

その上で、国分寺崖線（はけ）、野川、武蔵野公園に代表される豊かな自然環境が可能な限り保全されるよう、必要な働きかけを行ってまいります。